

Qué queremos hacer: archivo personal de salud

Product discovery · Versión 0.1 · 5 de octubre de 2026

1. Contexto y problema

En Chile, las personas no tienen a mano su propio historial de salud. Cada vez que consultan en una institución nueva se les vuelve a preguntar por enfermedades y alergias que otras instituciones ya conocen. Los diagnósticos suelen ser una fotografía del momento del paciente y no consideran su historia ni la de su familia.

Problemas observados:

- Las instituciones de salud y servicios cercanos, como la inscripción a una ISAPRE, piden preexistencias, y algunos diagnósticos se hacen sin el historial completo.
- Si la persona no guarda sus diagnósticos y recetas (por ejemplo, en fotos), no puede responder preguntas históricas y el médico pasa por alto el evento.
- El historial de la infancia se pierde si los padres no lo guardaron o ya no están.
- La información de la familia (por ejemplo, tiroides o hipertensión crónica) no se cruza con la del paciente.
- Problemas crónicos se tratan como algo contextual y no se detectan a tiempo.

2. Qué queremos hacer

Un archivo personal de salud en el que cada persona ordena, conserva y controla su propio historial, y puede compartir de forma selectiva solo lo necesario con médicos, instituciones o aseguradoras.

La idea original es construirlo sobre la blockchain Midnight, que permite probar hechos sin revelar los datos subyacentes. La primera versión se centra en el paciente y no en las instituciones.

3. Usuario inicial

Una persona que quiere ordenar su propio historial de salud.

4. Resultado deseado para esa persona

- Tener su historial reunido y ordenado cronológicamente.

- Llegar a una consulta con un resumen claro de alergias, medicamentos y condiciones crónicas.
- Compartir únicamente lo necesario en cada situación, con control y posibilidad de revocar.

5. Alcance por etapas

- **Etapas A:** historial personal consolidado (documentos, recetas, diagnósticos).
- **Etapas B:** compartir de forma selectiva con médicos y aseguradoras.
- **Etapas C:** antecedentes familiares estructurados.
- **Etapas D:** alertas de riesgo y hoja de ruta de alimentación y cuidados.

Propuesta de alcance inicial: etapas A y B. Las etapas C y D quedan para una fase posterior por su complejidad legal y clínica.

Fuera del alcance inicial:

- Guardar datos clínicos directamente en la blockchain.
- Recomendaciones de salud prescriptivas sin supervisión profesional.
- Cruzar fichas entre familiares sin el consentimiento de cada uno.

6. Principios de diseño (propuestos)

- El paciente controla sus datos y decide con quién compartirlos.
- Consentimiento por propósito, revocable.
- Cada dato indica su nivel de confiabilidad: autodeclarado, documento original o firmado por una institución.
- Privacidad desde el diseño, incluyendo los metadatos de consentimiento.
- Los datos clínicos no se almacenan en la cadena.

7. Hipótesis a validar

- Las personas sienten este problema lo suficiente como para ingresar sus documentos médicos.
- Estarían dispuestas a subir documentos médicos a una aplicación.
- A los médicos les resulta útil un resumen traído por el paciente.
- La divulgación selectiva aporta más valor que compartir un PDF.
- Una blockchain aporta algo que una plataforma federada o central no aporta.

8. Supuestos y riesgos

- El reglamento de la Ley 21.668 (interoperabilidad de fichas) sigue pendiente; no hay obligación técnica exigible por ahora.
- La Ley 21.719 (datos personales) rige desde el 1 de diciembre de 2026 y exige consentimiento explícito, evaluación de impacto y seguridad robusta para datos sensibles.
- Si la persona pierde su clave, pierde su historial; se necesita un mecanismo de recuperación.
- Procesar documentos médicos con IA de terceros implica tratar datos sensibles con un proveedor externo.
- Una aseguradora podría presionar para exigir más información de la necesaria.
- Las fichas se conservan por 15 años, por lo que el historial más antiguo puede no existir.
- No verificado: cómo aplica en Chile la regulación de software médico a las funciones de apoyo clínico.
- Midnight opera hoy en una fase federada con un grupo reducido de validadores.

9. Preguntas abiertas

- ¿Dónde viven los datos: en el dispositivo o cifrados en la nube?
- ¿Se usa Midnight desde la primera versión o se incorpora al llegar a la etapa B?
- ¿Plataforma móvil, web o ambas?
- ¿Cuál es el modelo de negocio? (por definir)
- ¿Qué métricas definen el éxito? (por definir)

10. Próximos pasos de discovery

1. Entrevistar a personas del usuario inicial para validar el problema y su frecuencia.
2. Mapear el recorrido actual de cada persona al reunir y presentar su historial.
3. Probar las hipótesis con un prototipo simple del flujo de ingreso de documentos.
4. Revisar la guía IPS-CL del MINSAL y seguir la publicación del reglamento de la Ley 21.668.
5. Validar los aspectos legales con un abogado especialista en datos personales y salud.